HER HAFTA BİR VAKA™ · ANA MATERYAL

52 Haftalık Vaka Çalışma Programı

Bir yıl, haftada bir konu. Her hafta tek hedef, Başucu Kitabı'nda okunacak bölüm, bir pratik vaka ve üç soruluk öz değerlendirme. Sistem kitapta kalmasın, koltuk başında refleks olsun.

İçindekiler

Bu program nasıl kullanılır

Modül 01 · Temeller ve Oklüzyonun 6 Anahtarı · Hafta 1–5

Modül 02 · Bütüncül Teşhis · Hafta 6–11

Modül 03 · Klinik Planlama: Problem Listesinden Mekaniğe · Hafta 12–16

Modül 04 · Yer Yönetimi: IPR, Genişletme, Çekimler ve Mini Vidalarla Ankraj · Hafta 17–23

Modül 05 · Sagital Problemler: Sınıf II ve Sınıf III · Hafta 24–31

Modül 06 · Vertikal ve Transversal Problemler · Hafta 32–38

Modül 07 · Yardımcı Mekanikler · Hafta 39–43

Modül 08 · Bitirme ve Stabilite · Hafta 44–48

Modül 09 · Yorumlu Klinik Vakalar · Hafta 49–52

Sonraki adım

Programı kendinize uyarlayın

- Sıra Başucu Kitabı'nın 9 modülünü izler. Bu hafta özellikle bir konuyla karşılaştıysanız o haftayı öne alabilirsiniz.
- Yoğun bir haftada yalnızca vakayı çözün; okuma ve soruları bir sonraki haftaya taşıyın, programı bırakmayın.
- Yorumlu vakalara (Hafta 49–52) gelmeden önce kaçırdığınız haftaları tamamlayın.
- İlerlemenizi Haftalık İlerleme Takip Kâğıdı'na işaretleyin. Aylık hedefler için 12 Aylık Klinik Gelişim Yol Haritası'na bakın.

BAŞLARKEN

Bu program nasıl kullanılır

Haftada toplam 30–40 dakika; iki hasta arasındaki boşluklara bölünebilecek kadar kısa.

> *Bir sistemi refleks hâline getiren şey tek bir uzun okuma değil, her hafta aynı sırayla yapılan kısa tekrardır.*

Haftanın ritmi

NE ZAMAN	SÜRE	NE YAPARSINIZ
Haftanın ilk günü	10–15 dk	Hedefi okuyun. Başucu Kitabı'nda ilgili modül bölümünü ve Görsel Haritaları açın.
Hafta ortası	10 dk	Haftanın vakasını yorumuna bakmadan çözün. Cevabınızı kutuya yazın, sonra yorumu okuyun.
Haftanın son günü	5–10 dk	Üç soruyu cevaplayın, kısa cevaplarla karşılaştırın. Takip kâğıdına işaretleyin.
Muayene sırasında	—	Haftanın konusuna uyan bir hastanız varsa aynı soruları kendi hastanıza sorun.

Her vakada aynı 4 adım

1. **Verileri okuyun.** Yaş, profil, molar ve kanin ilişkisi, overjet ve overbite, sefalometrik değerler, alışkanlıklar.
2. **Problem listesini yazın.** Sagital, vertikal, transversal ve yer başlıklarında.
3. **Kararı gerekçesiyle yazın.** Tek cümle: ne yapılır ve neden.
4. **Yorumla karşılaştırın.** Farklı düşündüyseniz Görsel Haritaya dönün ve farkı bir satırla not edin.

Vakalar eğitim amaçlıdır

Vakalardaki veriler kurgusaldır ve öğretmek için sadeleştirilmiştir. Gerçek hastada karar her zaman tam muayene ve kayıtlarla verilir. Vakanın sağ üstündeki **Temel**, **Orta** veya **İleri** etiketi zorluğu gösterir; İleri vakalarda yorumla tam örtüşmemeniz normaldir, amaç gerekçeyi kurmaktır.

MODÜL 01 · HAFTA 1–5

Temeller ve Oklüzyonun 6 Anahtarı

Bu bölümde 5 hafta var. Başlamadan önce Başucu Kitabı'nda Modül 01'in giriş sayfasını okuyun.

Hafta 1

Angle sınıflaması ve maloklüzyon tipleri

Modül 01

Haftanın hedefi	Her yeni hastada molar ve kanin ilişkisini iki tarafta ayrı ayrı, 30 saniyede ve doğru terimle yazabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 01 · Temeller ve Oklüzyonun 6 Anahtarı
Görsel Haritalar	Görsel Harita 1 (Angle Sınıflandırması) · Görsel Harita 2 (Maloklüzyon Tipleri)

Haftanın vakası

TEMEL

14 yaş, kız. Sağ ve sol molar ilişki Sınıf II tam birim, kanin ilişkisi Sınıf II. Overjet 7 mm, overbite 4 mm. Üst kesiciler prokline. Dudaklar dinlenmede kapanmıyor.

Soru: Angle sınıfını ve bölümünü yazın. Bu bilgi tek başına neyi söylemez?

Yorum: Sınıf II bölüm 1: artmış overjet ve prokline üst kesiciler. Angle sınıflaması yalnızca dişlerin sagital ilişkisini anlatır; iskeletsel kaynağı (maksiller mi, mandibular mı) ve vertikal paterni söylemez. Bunlar sefalometri ve klinik profille ayrılır.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Angle sınıflaması hangi ilişkiye dayanır?
2. Sınıf II bölüm 2'nin tipik kesici bulgusu nedir?
3. Molar ilişki sağda ve solda farklıysa ne yazarsınız?

Kısa cevaplar: 1. Üst birinci moların meziobukkal tüberkülünün alt birinci moların bukkal oluğuna göre konumu. **2.** Retrokline üst santraller (çoğu zaman prokline lateraller) ve derin kapanış. **3.** Her tarafı ayrı yazarsınız (ör. sağ Sınıf I, sol Sınıf II yarım birim) ve asimetrinin nedenini ararsınız.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 2

Oklüzyonun 6 anahtarı

Modül 01

Haftanın hedefi	Bitirme aşamasındaki bir vakaya bakıp altı anahtardan hangilerinin eksik olduğunu sırayla söyleyebilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 01 · Temeller ve Oklüzyonun 6 Anahtarı
Görsel Haritalar	Görsel Harita 7 (Oklüzyonun 6 Anahtarı)

Haftanın vakası

TEMEL

Tedavinin 18. ayı, bitirme kontrolü. Molar ilişki iki tarafta Sınıf I. Kesicilerde boşluk yok. Üst ikinci premolarlarda belirgin rotasyon var. Alt Spee eğrisi hâlâ yaklaşık 3 mm derin.

Soru: Altı anahtardan hangileri henüz sağlanmamış?

Yorum: Rotasyon olmaması (4. anahtar) ve düz ya da hafif oklüzal düzlem (6. anahtar) eksik. Rotasyonlu premolar ark içinde fazla yer kaplar ve kontakları bozar; derin Spee eğrisi derin kapanışın nüksüne zemin hazırlar.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Altı anahtarı sırayla sayın.
2. 1. anahtar yalnızca molar sınıfı mıdır?
3. Derin Spee eğrisi bitirmede neden sorun çıkarır?

Kısa cevaplar: 1. Molar ilişki, kron angulasyonu (tip), kron inklinasyonu (tork), rotasyon olmaması, sıkı kontaklar, düz oklüzal düzlem. **2.** Hayır. Üst birinci moların distal marjinal sırtının alt ikinci moların mezial marjinal sırtıyla temas etmesi de istenir. **3.** Üst dişlerin oturacağı yeri daraltır ve derin kapanış eğilimini sürdürür.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 3

Büyüme ve dişlenme dönemleri

Modül 01

Haftanın hedefi	Karma dişlenmedeki bir bulgunun normal gelişim mi, müdahale gerektiren bir sorun mu olduğunu ayırabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 01 · Temeller ve Oklüzyonun 6 Anahtarı
Görsel Haritalar	Görsel Harita 8 (Kraniyofasiyal Büyüme) · Görsel Harita 21 (Diş Sürme Kronolojisi) · Görsel Harita 22 (Süt Dişlenmesi: Normal Bulgular) · Görsel Harita 23 (Karma Dişlenme ve Leeway Aralığı)

Haftanın vakası

TEMEL

8 yaş, erkek. Alt daimi kesiciler sürmüş, alt kesicilerde yaklaşık 2 mm çapraşıklık. Süt kaninler ve süt molarlar yerinde, çürük yok. Molar ilişki Sınıf I.

Soru: Hemen tedavi gerekir mi? Hangi bilgiyle karar verirsiniz?

Yorum: Erken karma dişlenmede hafif alt kesici çapraşıklığı sık görülür. Yer analizi yapılır, leeway aralığı ve süt molarların korunması değerlendirilir; düzenli takip planlanır. Yer kaybı riski varsa leeway aralığını korumak (ör. lingual ark) seçenek olarak tartışılır.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Leeway aralığı nedir?
2. Primat boşlukları nerede bulunur?
3. Büyüme atılımına yakınlığı hangi kayıtla değerlendirirsiniz?

Kısa cevaplar: 1. Süt kanin ve süt molarların meziodistal toplamı ile yerlerine gelecek daimi dişlerin toplamı arasındaki fark. **2.** Üstte süt lateral ile süt kanin arasında, altta süt kanin ile birinci süt molar arasında. **3.** Servikal vertebra olgunlaşması (lateral sefalometride) veya el-bilek radyografisi; boy artışı öyküsüyle birlikte.

☐ Okudum ☐ Vakayı çözdüm ☐ 3 soruyu cevapladım ☐ Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 4

Biyomekanik: kuvvet, moment ve hareket tipleri

Modül 01

Haftanın hedefi	Bir diş hareketinin neden istenmeyen şekilde gerçekleştiğini direnç merkezi ve moment/kuvvet oranıyla açıklayabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 01 · Temeller ve Oklüzyonun 6 Anahtarı
Görsel Haritalar	Görsel Harita 24 (Biyomekanik: Kuvvet ve Moment) · Görsel Harita 25 (Diş Hareketi Tipleri) · Görsel Harita 26 (Kuvvet Büyüklüğü ve Hareket Hızı)

Haftanın vakası

ORTA

Üst birinci premolar çekimli vaka. Kaninin distalizasyonunda kanin kronu distale devriliyor, kök meziale kalıyor. Kullanılan tel ince ve yuvarlak, kuvvet kronda uygulanıyor.

Soru: Bu hareketin adı nedir ve neden oluyor? Ne değiştirirsiniz?

Yorum: Kontrolsüz tipping. Kuvvet direnç merkezinin kronal tarafından uygulanıyor ve karşı moment yetersiz (düşük M/F oranı). Daha rijit ve slotu daha iyi dolduran bir tel, hafif kuvvet ve yeterli anti-tip momenti ile kontrollü harekete yaklaşılır.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Direnç merkezi nedir?
2. Translasyon için ne gerekir?
3. Kontrollü ve kontrolsüz tipping farkı nedir?

Kısa cevaplar: 1. Kuvvet buradan geçtiğinde dişin dönmeden (translasyonla) hareket ettiği nokta. **2.** Kuvvetin oluşturduğu momenti dengeleyen yeterli karşı moment, yani daha yüksek bir M/F oranı. **3.** Kontrollüde dönme merkezi kök ucuna yakındır; kontrolsüzde kök ters yöne hareket eder.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 5

Doku cevabı, kök rezorpsiyonu, braket ve tel sıralaması

Modül 01

Haftanın hedefi	Tedavi öncesinde kök rezorpsiyonu riskini fark edip kayda geçirmek ve tel sıralamasının mantığını anlatabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 01 · Temeller ve Oklüzyonun 6 Anahtarı
Görsel Haritalar	Görsel Harita 27 (Kök Rezorpsiyonu Riski) · Görsel Harita 28 (Periodontal Ligament ve Kemik Yeniden Yapılanması) · Görsel Harita 29 (Braket Preskripsiyonu: Tork, Tip ve Offset) · Görsel Harita 30 (Ark Teli Malzemeleri ve Sıralama)

Haftanın vakası

ORTA

22 yaş, kadın. Daha önce ortodontik tedavi görmüş. Panoramikte üst kesicilerin kökleri kısa ve küt görünüyor. Yeni şikâyeti alt kesicilerde çapraşıklık.

Soru: Tedaviye başlamadan önce ne yaparsınız?

Yorum: Bulguyu başlangıç kaydına yazın ve hastayı bilgilendirin. Hedefleri sınırlı tutmayı, hafif kuvvetleri, gereksiz kök hareketinden kaçınmayı ve tedavi sırasında radyografik kontrolü planlayın. Önceki tedavinin kayıtları varsa isteyin.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Kök rezorpsiyonu için iki risk faktörü sayın.
2. Tel sıralamasının genel mantığı nedir?
3. TMA hangi aşamada işe yarar?

Kısa cevaplar: 1. Ağır veya uzun süreli kuvvet, uzun tedavi süresi, önceki rezorpsiyon, ince ya da sivri kök morfolojisi, travma öyküsü. **2.** Esnek NiTi ile seviyeleme, ardından daha büyük boyutlu teller, sonra çalışma ve bitirme için rektangüler (çoğu zaman çelik) teller. **3.** Çelikten daha esnek, NiTi'den daha bükülebilir olduğu için bitirme bükümleri ve orta düzey kuvvet gereken aşamalarda.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

MODÜL 02 · HAFTA 6–11

Bütüncül Teşhis

Bu bölümde 6 hafta var. Başlamadan önce Başucu Kitabı'nda Modül 02'in giriş sayfasını okuyun.

Hafta 6

Anamnez ve ekstraoral muayene: profil ve simetri

Modül 02

Haftanın hedefi	Her ilk muayenede anamnez, profil ve simetri bulgularını aynı sırayla ve eksiksiz not edebilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 02 · Bütüncül Teşhis
Görsel Haritalar	Görsel Harita 31 (Ortodontik Anamnez) · Görsel Harita 32 (Ekstraoral Muayene: Profil) · Görsel Harita 33 (Yüz Simetrisi)

Haftanın vakası

TEMEL

16 yaş, kız. Konveks profil, çene ucu geride. Dinlenmede dudaklar kapanmıyor, kapatırken mentalis kası kasılıyor. Yüz önden simetrik. Genel sağlık öyküsünde bilinen bir sorun yok.

Soru: Bu bulgulardan hangi ön değerlendirmeyi yazarsınız ve neyle doğrularsınız?

Yorum: Konveks profil ve geride çene ucu mandibular retrüzyonu düşündürür. Dudak yetmezliği kesici proklinasyonuna ya da vertikal fazlalığa eşlik edebilir. Sefalometri (SNB, ANB, FMA) ve intraoral bulgularla doğrulanır.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Anamnezde atlanmaması gereken üç başlık sayın.
2. Profil hangi üç tipe ayrılır?
3. Yüz simetrisini nasıl kontrol edersiniz?

Kısa cevaplar: 1. Genel sağlık ve ilaç kullanımı, travma öyküsü, alışkanlıklar, TME şikâyeti, büyüme ve aile öyküsü. **2.** Düz, konveks ve konkav. **3.** Hasta karşıdan, baş doğal pozisyondayken yüz orta hattı, çene ucu ve dişsel orta hatları birlikte değerlendirilir; şüphede fotoğrafla kaydedilir.

☐ Okudum ☐ Vakayı çözdüm ☐ 3 soruyu cevapladım ☐ Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 7

Gülüş analizi ve intraoral muayene

Modül 02

Haftanın hedefi	Gülüş ve intraoral muayenede vertikal ve transversal ipuçlarını yakalayabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 02 · Bütüncül Teşhis
Görsel Haritalar	Görsel Harita 34 (Gülüş Analizi) · Görsel Harita 35 (İntraoral Muayene)

Haftanın vakası

ORTA

25 yaş, kadın. Gülüşte üst dişetinin belirgin bir kısmı görünüyor. Dinlenmede üst kesici görünürlüğü fazla. Üst dudak boyu klinik olarak normal görünüyor. Kesici kronları normal uzunlukta.

Soru: Dişeti gülüşünün olası nedenleri nelerdir? Bu tabloda hangisi öne çıkar?

Yorum: Olası nedenler: vertikal maksiller fazlalık, üst kesici ekstrüzyonu, kısa veya hiperaktif üst dudak, pasif sürme. Dudak boyu ve kron uzunluğu normal olduğu için vertikal maksiller fazlalık veya dentoalveolar ekstrüzyon öne çıkar; sefalometri ile değerlendirilir.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Dinlenmede üst kesici görünürlüğü neden önemlidir?
2. Orta hatları nasıl kaydedersiniz?
3. İntraoral muayenede beş başlık sayın.

Kısa cevaplar: 1. Derin kapanışta intrüzyon kararını ve vertikal patern değerlendirmesini doğrudan etkiler. **2.** Üst ve alt dişsel orta hat ayrı ayrı yüz orta hattına göre, sağ veya sol ve mm olarak. **3.** Ağız hijyeni ve dişeti, eksik veya fazla dişler, çapraşıklık ve boşluklar, kapanış ilişkileri (üç boyutta), restorasyonlar ve çürükler.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 8

Fonksiyonel muayene: TME, ağız açıklığı ve fonksiyonel kayma

Modül 02

Haftanın hedefi	Sentrik ilişki ile sentrik oklüzyon arasındaki farkı her hastada kontrol etmeyi alışkanlık hâline getirmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 02 · Bütüncül Teşhis
Görsel Haritalar	Görsel Harita 36 (Fonksiyonel Muayene: TME ve Ağız Açıklığı) · Görsel Harita 89 (Fonksiyonel Kayma)

Haftanın vakası

ORTA

9 yaş, kız. Sentrik oklüzyonda sağ tarafta posterior çapraz kapanış ve alt orta hatta sağa kayma var. Mandibula yönlendirilerek sentrik ilişkiye getirildiğinde orta hatlar çakışıyor ve posteriorda uç uca temas görülüyor.

Soru: Tanınız nedir? Neden erken ele alınması önerilir?

Yorum: Üst çene darlığına bağlı fonksiyonel kayma. Kayma sürdükçe asimetrik bir kapanış alışkanlığı ve büyümeyle yerleşen asimetri riski oluşur. Üst çenenin transversal düzeltilmesi erken dönemde değerlendirilir.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. CR-CO farkını nasıl kontrol edersiniz?
2. TME muayenesinde not edilecek üç bulgu sayın.
3. Fonksiyonel kaymayı gerçek asimetriden ayıran temel bulgu nedir?

Kısa cevaplar: 1. Hastayı rahatlatıp mandibulayı nazikçe yönlendirerek ilk temas noktasını ve kaymanın yönünü gözlemleyerek. **2.** Ağız açıklığı miktarı, açılmada deviasyon veya defleksiyon, eklem sesi, palpasyonda hassasiyet. **3.** Sentrik ilişkide orta hatların düzelmesi.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 9

Model analizi, yer analizi ve Bolton

Modül 02

Haftanın hedefi	Bir arktaki yer ihtiyacını Spee eğrisi ve kesici pozisyonuyla birlikte hesaplayabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 02 · Bütüncül Teşhis
Görsel Haritalar	Görsel Harita 37 (Model Analizi) · Görsel Harita 38 (Bolton Analizi) · Görsel Harita 18 (Yer Analizi)

Haftanın vakası

ORTA

15 yaş, Sınıf I. Alt arkta dişlerin meziodistal toplamı 72 mm, mevcut ark uzunluğu 66 mm. Alt Spee eğrisi 2,5 mm. Alt kesiciler normal eğimde, profil düz.

Soru: Alt arktaki çapraşıklık ne kadar? Toplam yer ihtiyacını nasıl yorumlarsınız?

Yorum: Çapraşıklık 6 mm (orta düzey). Spee eğrisinin düzeltilmesi de ek yer ister, bu yüzden toplam ihtiyaç 6 mm'den fazladır. Profil düz ve kesiciler normal eğimde olduğu için kesicileri öne alarak yer kazanmanın sınırlı olduğu da hesaba katılır.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Bolton analizi neyi ölçer?
2. Yer analizinde en sık unutulan iki etken nedir?
3. Çapraşıklık şiddeti için sık kullanılan sınıflama nedir?

Kısa cevaplar: 1. Üst ve alt dişlerin meziodistal boyutları arasındaki orantıyı (anterior ve toplam). **2.** Spee eğrisinin düzeltilmesi ve planlanan kesici pozisyonu. **3.** Yaklaşık 4 mm'ye kadar hafif, 4–8 mm orta, 8 mm üzeri şiddetli; kliniğinizin kullandığı eşikleri esas alın.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 10

Panoramik okuma ve gömülü kaninler

Modül 02

Haftanın hedefi	Panoramiği her seferinde aynı sırayla okuyup gömülü kanin riskini erken fark edebilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 02 · Bütüncül Teşhis
Görsel Haritalar	Görsel Harita 39 (Panoramik Radyografi Okuma) · Görsel Harita 17 (Gömülü Kaninler)

Haftanın vakası

ORTA

11 yaş, erkek. Sol üst kanin bukkalde palpe edilemiyor, sağ taraf palpe ediliyor. Panoramikte sol üst kanin kronu lateral kesicinin kökü ile örtüşüyor. Süt kanin yerinde ve mobil değil.

Soru: Bu bulgu ne düşündürür? Sonraki adımlarınız nelerdir?

Yorum: Gömülü kanin riski. Lateral kesici kökünde rezorpsiyon açısından dikkatli değerlendirme gerekir. Pozisyonun netleştirilmesi için ek görüntüleme (gerekirse 3B) endikasyonu değerlendirilir. Süt kaninin çekimi erken müdahale seçeneği olarak tartışılır; karar pozisyona ve yere göre verilir.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Panoramikte sistematik okuma sırası nasıl olmalıdır?
2. Kanin palpasyonu hangi dönemde anlam kazanır?
3. Gömülü kaninde hangi komşu yapı mutlaka kontrol edilir?

Kısa cevaplar: 1. Önce genel yapı ve simetri, sonra kemik ve sinüsler, ardından diş sayısı, gelişim, kökler ve patoloji; her seferinde aynı sırayla (Araç 1). **2.** Yaklaşık 10 yaş civarından itibaren; tek taraflı palpe edilememe uyarı işaretidir. **3.** Lateral (ve gerekirse santral) kesicinin kökü, rezorpsiyon açısından.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 11

Lateral sefalometri: Steiner analizi ve vertikal patern

Modül 02

Haftanın hedefi	Bir sefalometrik değer setini sagital, vertikal ve dental olarak üç cümleyle özetleyebilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 02 · Bütüncül Teşhis
Görsel Haritalar	Görsel Harita 40 (Lateral Sefalometri: Noktalar ve Düzlemler) · Görsel Harita 41 (Steiner Analizi: SNA, SNB, ANB) · Görsel Harita 42 (Vertikal Patern: FMA ve SN-GoMe) · Görsel Harita 3 (Sefalometrik Analiz)

Haftanın vakası

ORTA

13 yaş, kız. SNA 82°, SNB 76°, ANB 6°, FMA 32°, IMPA 98°. Klinikte konveks profil ve artmış overjet.

Soru: Bu değerleri üç cümleyle yorumlayın.

Yorum: Sagital: mandibular retrüzyona bağlı iskeletsel Sınıf II (SNA normal, SNB düşük). Vertikal: FMA normalin üzerinde, hiperdiverjan eğilim. Dental: alt kesiciler prokline, Sınıf II'ye dentoalveolar kompansasyon.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. ANB için sık kullanılan norm nedir?
2. FMA için klasik norm nedir?
3. ANB hangi durumda yanıltıcı olabilir? Ne eklersiniz?

Kısa cevaplar: 1. Yaklaşık 2° ± 2°. **2.** Yaklaşık 25°. **3.** SN düzleminin eğimi veya Nasion'un konumu farklıysa; Wits değerlendirmesi ve klinik profil eklenir.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

MODÜL 03 · HAFTA 12–16

Klinik Planlama: Problem Listesinden Mekaniğe

Bu bölümde 5 hafta var. Başlamadan önce Başucu Kitabı'nda Modül 03'in giriş sayfasını okuyun.

Hafta 12

Problem listesi ve önceliklendirme

Modül 03

Haftanın hedefi	Bir vakanın problem listesini sagital, vertikal, transversal ve yer başlıklarında yazıp önceliklendirebilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 03 · Klinik Planlama: Problem Listesinden Mekaniğe
Görsel Haritalar	Görsel Harita 43 (Problem Listesi) · Görsel Harita 44 (Tedavi Hedeflerini Önceliklendirme) · Görsel Harita 19 (Ortodontik Planlama)

Haftanın vakası

ORTA

13 yaş, erkek. Sınıf II bölüm 1, overjet 8 mm, overbite 5 mm. Üstte 4 mm, altta 3 mm çapraşıklık. Dudak yetmezliği. Hastanın şikâyeti: "Dişlerim önde."

Soru: Problem listesini dört başlıkta yazın ve önceliği belirleyin.

Yorum: Sagital: artmış overjet, Sınıf II molar ilişki. Vertikal: derin kapanış. Transversal: belirgin sorun yok (kontrol edilir). Yer: üst 4 mm, alt 3 mm çapraşıklık. Öncelik: hastanın şikâyeti ve travma riskiyle örtüşen sagital problem; büyüme dönemi bu problem için fırsattır. Derin kapanış sagital düzeltmeyle birlikte planlanır.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Problem listesi hangi başlıklarda yazılır?
2. Hastanın şikâyeti listede nerede durur?
3. Hedef ile mekanik arasındaki fark nedir?

Kısa cevaplar: 1. Sagital, vertikal, transversal, yer (çapraşıklık/boşluk) ve hastanın şikâyeti; gerekiyorsa periodontal ve fonksiyonel notlar. **2.** Ayrı ve görünür bir satırda; tedavi hedeflerinden biri mutlaka bu şikâyete cevap vermelidir. **3.** Hedef neyin değişeceğini, mekanik bunun hangi aparey ve kuvvetle yapılacağını söyler; mekanik hedeften sonra seçilir.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 13

Erken mi, geç mi? Büyüme dönemi kararları

Modül 03

Haftanın hedefi	Erken tedavinin gerçekten fayda sağladığı durumları, beklemenin daha doğru olduğu durumlardan ayırabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 03 · Klinik Planlama: Problem Listesinden Mekaniğe
Görsel Haritalar	Görsel Harita 45 (Erken mi, Geç mi Tedavi?) · Görsel Harita 91 (Sütür Olgunluğu ve Yaş)

Haftanın vakası

ORTA

8 yaş, kız. Üst sağ santral kesici çapraz kapanışta, diğer kesiciler normal. Sentrik ilişkide kesici uç uca gelebiliyor. Alt kesicide labial dişetinde hafif çekilme başlamış.

Soru: Erken tedavi endikasyonu var mı? Gerekçeniz nedir?

Yorum: Evet. Tek kesici anterior çapraz kapanış, fonksiyonel kayma ve alt kesicide periodontal zorlanma bulgusu erken düzeltmenin klasik gerekçeleridir. Yer yeterliyse kısa ve basit bir mekanikle düzeltilmesi değerlendirilir.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Erken tedavinin üç klasik endikasyonunu sayın.
2. Ne zaman beklemek daha doğrudur?
3. Büyüme atılımı Sınıf II tedavisinde neden önemlidir?

Kısa cevaplar: 1. Fonksiyonel kayma yapan çapraz kapanış, travma riski taşıyan artmış overjet, yer kaybını önleme, zararlı alışkanlıklar, erken Sınıf III. **2.** Problem büyümeyle kötüleşmiyorsa ve tedavi tek fazda, daha kısa sürede yapılabilecekse. **3.** Fonksiyonel apareylerle iskeletsel katkının en çok beklendiği dönemdir.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 14

Kamuflaj mı, cerrahi mi? VTO

Modül 03

Haftanın hedefi	Bir erişkin iskeletsel vakada kamuflajın sınırlarını ve cerrahi konsültasyonun ne zaman gerektiğini söyleyebilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 03 · Klinik Planlama: Problem Listesinden Mekaniğe
Görsel Haritalar	Görsel Harita 46 (Kamuflaj mı, Cerrahi mi?) · Görsel Harita 47 (Görsel Tedavi Hedefi (VTO)) · Görsel Harita 76 (Ortognatik Cerrahi Ne Zaman?)

Haftanın vakası

İLERİ

19 yaş, erkek. Sınıf III. ANB −4°, Wits −8 mm. Alt kesiciler retrokline (IMPA 80°), negatif overjet −3 mm. Hasta profilinden memnun değil ve çenesinin önde olmasından şikâyetçi.

Soru: Kamuflaj uygun mu? Hastaya hangi seçenekleri anlatırsınız?

Yorum: Alt kesiciler zaten retrokline olduğu için kamuflaj payı az, hastanın şikâyeti de iskeletsel ve estetik. Ortognatik cerrahi konsültasyonu önerilir; cerrahi planda dekompansasyon gerekir. Seçenekler, beklenen sınırlarla birlikte açıkça anlatılır.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Kamuflaj için uygun koşullar nelerdir?
2. Cerrahi planlarken büyümenin durumu neden önemlidir?
3. VTO ne işe yarar?

Kısa cevaplar: 1. Hafif-orta iskeletsel uyumsuzluk, kabul edilebilir profil, kesicilerde kompansasyon payı ve hastanın estetik beklentisinin uyumlu olması. **2.** Büyüme sürüyorsa sonuç değişebilir; özellikle Sınıf III'te büyümenin tamamlanması beklenir. **3.** Planlanan değişikliklerin profile ve oklüzyona olası etkisini önceden görmeye; kesin sonuç garantisi değildir.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 15

Mekanik sıra ve hasta uyumu

Modül 03

Haftanın hedefi	Uyum sorununu erken fark edip planı uyuma daha az bağımlı mekaniğe uyarlayabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 03 · Klinik Planlama: Problem Listesinden Mekaniğe
Görsel Haritalar	Görsel Harita 48 (Mekanik Sıra) · Görsel Harita 49 (Hasta Uyumunu Değerlendirme)

Haftanın vakası

ORTA

15 yaş, erkek. Sınıf II elastikleri kullanması gerekiyor. Son üç randevuda molar ilişki değişmemiş, elastik kullanımını "bazen unutuyorum" diye anlatıyor.

Soru: Ne yaparsınız?

Yorum: Uyumu açık ve suçlamadan konuşun, hedefi hasta ve aileyle yeniden netleştirin. Kullanımı kolaylaştıracak somut bir plan yapın. Uyum düzelmezse uyumdan daha bağımsız seçenekleri (sabit fonksiyonel aparey veya mini vida destekli mekanik) değerlendirin ve planı kayda geçirin.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Mekanik sıranın tipik basamaklarını sayın.
2. Uyuma bağımlı iki aparey veya mekanik sayın.
3. Araç 4'ün dört aşaması nelerdir?

Kısa cevaplar: 1. Seviyeleme-hizalama, çalışma aşaması (boşluk kapama ve sagital düzeltme), bitirme, pekiştirme. **2.** Elastikler, hareketli fonksiyonel apareyler, hareketli plaklar, ekstraoral aparatlar. **3.** Teşhis → Hedefler → Mekanik → Kontrol.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 16

Erişkin, periodontal riskli ve multidisipliner hasta

Modül 03

Haftanın hedefi	Erişkin ve periodontal riskli hastada ortodontinin hangi koşullarda ve hangi ekip sırasıyla yapılacağını planlayabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 03 · Klinik Planlama: Problem Listesinden Mekaniğe
Görsel Haritalar	Görsel Harita 50 (Erişkin Hastada Planlama) · Görsel Harita 51 (Periodontal Riskli Hasta) · Görsel Harita 52 (Multidisipliner Vakalar: İmplant ve Protez)

Haftanın vakası

İLERİ

42 yaş, kadın. Periodontal tedavi görmüş, hastalık şu an stabil. Alt kesicilerde yelpazelenme ve diastemalar. Sol alt birinci molar eksik, implant planlanıyor.

Soru: Planlamada hangi sırayı izlersiniz?

Yorum: Periodontal stabilitenin periodontoloğun onayıyla doğrulanması, hafif kuvvetlerle kesicilerin toplanması ve implant yerinin ortodontik olarak hazırlanması. İmplantın konumu ve zamanı ekip olarak birlikte belirlenir. Pekiştirme planı başta yapılır.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Periodontal hastada ortodontiye başlamanın şartı nedir?
2. İmplant ortodontiden önce mi sonra mı?
3. Erişkinde dikkat edilecek iki nokta sayın.

Kısa cevaplar: 1. Aktif hastalığın tedavi edilmiş ve stabil olması, düzenli periodontal takip. **2.** Çoğunlukla diş hareketleri bittikten sonra; implant ankraj olarak kullanılacaksa konumu ortodontik hedefe göre önceden planlanır. **3.** Büyüme katkısının olmaması, periodontal destek, restorasyonlar ve eksik dişler, sınırlı hedefler.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

MODÜL 04 · HAFTA 17–23

Yer Yönetimi: IPR, Genişletme, Çekimler ve Mini Vidalarla Ankraj

Bu bölümde 7 hafta var. Başlamadan önce Başucu Kitabı'nda Modül 04'in giriş sayfasını okuyun.

Hafta 17

Çekim kararı: endikasyonlar ve sınırlar

Modül 04

Haftanın hedefi	Çekim ya da koruma kararını çapraşıklık, profil ve kesici pozisyonuyla gerekçelendirebilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 04 · Yer Yönetimi: IPR, Genişletme, Çekimler ve Mini Vidalarla Ankraj
Görsel Haritalar	Görsel Harita 53 (Çekim Endikasyonları) · Görsel Harita 55 (Çekimsiz Tedavinin Sınırları)

Haftanın vakası

ORTA

17 yaş, kadın. Sınıf I. Üstte 7 mm, altta 8 mm çapraşıklık. Bimaksiller protrüzyon, dudaklar önde ve gergin. Periodontal durum iyi.

Soru: Çekim lehine ve aleyhine olan bulguları yazın. Kararınız nedir?

Yorum: Lehine: orta-şiddetli çapraşıklık, protrüzyon ve dudak protrüzyonu. Aleyhine belirgin bir bulgu yok. Çekimli plan güçlü aday; karar Araç 2 ile ve profil hedefiyle birlikte verilir.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Çekim lehine üç bulgu sayın.
2. Çekimsiz tedavinin sınırı nedir?
3. Düz profilli bir hastada çekim neden dikkatle düşünülür?

Kısa cevaplar: 1. Şiddetli çapraşıklık, dişsel protrüzyon ve dudak protrüzyonu, kesicilerin kaide kemik sınırında olması. **2.** Kesicileri aşırı öne almadan ve genişletmeyi biyolojik sınırların ötesine taşımadan yer kazanılamıyorsa. **3.** Kesicilerin geri alınması profili daha da düzleştirebilir.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 18

Hangi dişler çekilir?

Modül 04

Haftanın hedefi	Çekim kombinasyonunu ankraj ihtiyacına ve bitirme hedefine göre seçebilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 04 · Yer Yönetimi: IPR, Genişletme, Çekimler ve Mini Vidalarla Ankraj
Görsel Haritalar	Görsel Harita 54 (Premolar Çekim Seçenekleri) · Görsel Harita 72 (Sınıf II Kamuflaj Çekimleri)

Haftanın vakası

ORTA

16 yaş, kız. Sınıf II bölüm 1, molar Sınıf II tam birim. Overjet 7 mm. Alt arkta çapraşıklık yok ve alt kesiciler normal eğimde. Büyüme büyük ölçüde tamamlanmış.

Soru: Hangi çekim kombinasyonu düşünülebilir? Bitirmede molar ilişki ne olur?

Yorum: Yalnızca üst birinci premolar çekimiyle kamuflaj düşünülebilir. Bitirmede molar ilişki Sınıf II, kanin ilişkisi Sınıf I olur. Alt arkta yer ihtiyacı olmadığı için alt çekime gerek yoktur.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Dört premolar çekimi ile iki üst premolar çekimi arasındaki temel fark nedir?
2. Alt ikinci premolar ne zaman birinci premolara tercih edilebilir?
3. Çekim kararından önce hangi aracı açarsınız?

Kısa cevaplar: 1. İki üst çekimde alt ark korunur ve molar Sınıf II bitirilir; dört çekimde molar ilişki Sınıf I'e getirilmeye çalışılır. **2.** Alt kesicilerin az geri gelmesi ve molarların meziale hareketi istendiğinde. **3.** Araç 2 · Karar Haritası: Çekim mi, Koruma mı?

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 19

IPR (stripping) protokolü

Modül 04

Haftanın hedefi	IPR'nin uygun ve uygun olmayan durumlarını ayırıp miktarı ölçerek planlayabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 04 · Yer Yönetimi: IPR, Genişletme, Çekimler ve Mini Vidalarla Ankraj
Görsel Haritalar	Görsel Harita 56 (IPR (Stripping) Protokolü)

Haftanın vakası

ORTA

28 yaş, kadın. Alt kesicilerde 3 mm çapraşıklık. Kesici kronları üçgen formda, kontaklar insizale yakın. Ağız hijyeni iyi, çürük riski düşük.

Soru: IPR uygun mu? Nelere dikkat edersiniz?

Yorum: Uygun bir seçenek. Üçgen kron formu IPR'yi destekler ve siyah üçgen riskini azaltabilir. Miktar ölçülerek ve dişler arasında dengeli dağıtılarak planlanır, mine kalınlığı sınırları gözetilir, yüzeyler cilalanır. Bolton sonucu da hesaba katılır.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. IPR'nin uygun olduğu iki durum sayın.
2. IPR'den kaçınılması gereken iki durum sayın.
3. IPR sonrası yüzeyle ilgili ne yapılır?

Kısa cevaplar: 1. Hafif-orta çapraşıklık, üçgen kron formu, Bolton uyumsuzluğu, profilin kesicileri öne almaya izin vermemesi. **2.** Yüksek çürük riski, yetersiz ağız hijyeni, küçük veya dar kronlar, ileri hassasiyet. **3.** Yüzey düzeltilir ve cilalanır; hastaya ağız hijyeni hatırlatılır.

☐ Okudum ☐ Vakayı çözdüm ☐ 3 soruyu cevapladım ☐ Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 20

Transversal genişletme ve RME

Modül 04

Haftanın hedefi	Dental ve iskeletsel genişletme ihtiyacını ayırıp yaşa uygun yöntemi seçebilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 04 · Yer Yönetimi: IPR, Genişletme, Çekimler ve Mini Vidalarla Ankraj
Görsel Haritalar	Görsel Harita 57 (Arkı Genişletme: Dental mi, İskeletsel mi?) · Görsel Harita 58 (Hızlı Üst Çene Genişletmesi (RME)) · Görsel Harita 92 (Genişletmede Dişeti ve Kemik Sınırları)

Haftanın vakası

ORTA

10 yaş, erkek. Bilateral posterior çapraz kapanış. Üst çene dar, damak derin. Fonksiyonel kayma yok. Dişeti sağlıklı.

Soru: Hangi tip genişletme uygundur? Neden?

Yorum: İskeletsel transversal darlık; büyüme döneminde sütür henüz açıkken hızlı üst çene genişletmesi (RME) uygun bir seçenektir. Genişletmeden sonra pekiştirme dönemi planlanır.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Dental ve iskeletsel genişletme farkı nedir?
2. Yaş arttıkça sütür nasıl değişir?
3. Genişletmeden sonra neden pekiştirme gerekir?

Kısa cevaplar: 1. Dentalde dişler bukkale eğilir; iskeletselde orta palatal sütür açılarak üst çene kaide kemiği genişler. **2.** Giderek olgunlaşır ve açılmaya direnci artar. **3.** Açılan bölgenin yeniden yapılanması için zaman gerekir; aksi hâlde nüks olabilir.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 21

Distalizasyon, yer tutucular ve karma dişlenmede yer

Modül 04

Haftanın hedefi	Erken süt dişi kaybından sonra yer kaybını önleme ya da geri kazanma kararını verebilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 04 · Yer Yönetimi: IPR, Genişletme, Çekimler ve Mini Vidalarla Ankraj
Görsel Haritalar	Görsel Harita 59 (Distalizasyon) · Görsel Harita 60 (Yer Tutucular) · Görsel Harita 61 (Karma Dişlenmede Yer Kazanımı)

Haftanın vakası

ORTA

9 yaş, kız. Sol alt ikinci süt molar çürük nedeniyle erken çekilmiş. Sol alt birinci daimi molar meziale eğilmeye başlamış. Panoramikte alttan gelen ikinci premoların sürmesine daha zaman var.

Soru: Ne yaparsınız?

Yorum: Yer kaybı riski var. Yer analizi yapılır; kayıp henüz yoksa yer tutucu, kayıp başladıysa yer kazanımı seçenekleri değerlendirilir. Alttaki dişin gelişim durumu ve karşı arkın durumu da hesaba katılır.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Yer tutucunun temel endikasyonu nedir?
2. Erken süt molar kaybının tipik sonucu nedir?
3. Distalizasyonda ankraj kaybı nerede görülür?

Kısa cevaplar: 1. Süt dişinin erken kaybı ve alttaki daimi dişin sürmesine daha zaman olması. **2.** Daimi moların meziale hareketi ve premolar için yer kaybı. **3.** Premolar ve kesicilerin meziale hareketinde ve kesici proklinasyonunda.

☐ Okudum ☐ Vakayı çözdüm ☐ 3 soruyu cevapladım ☐ Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 22

Ankraj: TPA, Nance ve ankraj kaybı

Modül 04

Haftanın hedefi	Ankraj ihtiyacını vakanın başında sınıflayıp ankraj kaybını erken fark edebilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 04 · Yer Yönetimi: IPR, Genişletme, Çekimler ve Mini Vidalarla Ankraj
Görsel Haritalar	Görsel Harita 11 (Ankraj Kontrolü) · Görsel Harita 65 (Transpalatal Bar ve Nance Apareyi) · Görsel Harita 66 (Ankraj Kaybı Belirtileri)

Haftanın vakası

İLERİ

Üst birinci premolar çekimli Sınıf II kamuflaj. Boşluk kapama sırasında üst molarlar yaklaşık 3 mm meziale gelmiş, overjet beklenenden az azalmış. Başlangıçta ek ankraj planlanmamış.

Soru: Sorun nedir? Başlangıçta ne planlanmalıydı?

Yorum: Ankraj kaybı. Bu vaka maksimum ankraj gerektiriyordu; başlangıçta TPA veya Nance gibi destekler ya da mini vida ile ankraj planlanmalıydı. Şimdi kalan boşluk ve hedef yeniden değerlendirilir, ankraj desteği eklenir.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Ankraj ihtiyacı hangi üç düzeyde sınıflanır?
2. Ankraj kaybının iki belirtisini sayın.
3. TPA ile Nance arasındaki fark nedir?

Kısa cevaplar: 1. Minimum, orta ve maksimum. **2.** Molarların meziale gelmesi, molar ilişkinin bozulması, overjetin beklenenden az azalması, molar tipping. **3.** TPA palatinal bir bar ile molarları birbirine bağlar; Nance ön damakta akrilik butonla mukozadan destek alır.

☐ Okudum ☐ Vakayı çözdüm ☐ 3 soruyu cevapladım ☐ Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 23

Mini vidalar (TAD)

Modül 04

Haftanın hedefi	Mini vida yerleşimini planlarken kontrol edilecek noktaları ve başarısızlık nedenlerini sayabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 04 · Yer Yönetimi: IPR, Genişletme, Çekimler ve Mini Vidalarla Ankraj
Görsel Haritalar	Görsel Harita 62 (Mini Vida Yerleştirme Bölgeleri) · Görsel Harita 63 (Mini Vida ile İntrüzyon) · Görsel Harita 64 (Mini Vida ile Distalizasyon)

Haftanın vakası

İLERİ

38 yaş, erkek. Sol üst birinci molar, karşıdaki alt moların kaybı nedeniyle ekstrüze olmuş. Protez için dikey yer gerekiyor. Periodontal durum stabil.

Soru: Hangi mekanik düşünülebilir? Planlamada neye bakarsınız?

Yorum: Mini vida destekli intrüzyon düşünülebilir (çoğu zaman bukkal ve palatinal destekle). Kökler arası mesafe ve kemik miktarı radyografik olarak değerlendirilir, yapışık dişeti tercih edilir. Protez hekimiyle hedef dikey boyut birlikte belirlenir.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Mini vida yerleşim bölgesinde kontrol edilecek iki nokta sayın.
2. Mini vida başarısızlığının üç nedenini sayın.
3. Direkt ve indirekt ankraj farkı nedir?

Kısa cevaplar: 1. Kökler arası mesafe, kemik miktarı, yapışık dişeti, anatomik yapılara yakınlık. **2.** Kök teması, yetersiz kemik, çevresinde enflamasyon, aşırı erken veya fazla yükleme. **3.** Direktte kuvvet doğrudan mini vidadan uygulanır; indirektte mini vida bir dişi sabitler ve kuvvet o dişten uygulanır.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

MODÜL 05 · HAFTA 24–31

Sagital Problemler: Sınıf II ve Sınıf III

Bu bölümde 8 hafta var. Başlamadan önce Başucu Kitabı'nda Modül 05'in giriş sayfasını okuyun.

Hafta 24

Sınıf II: dental mi, iskeletsel mi?

Modül 05

Haftanın hedefi	Sınıf II molar ilişkisinin dental mi iskeletsel mi olduğunu klinik ve sefalometriyle ayırabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 05 · Sagital Problemler: Sınıf II ve Sınıf III
Görsel Haritalar	Görsel Harita 12 (Sınıf II: Dental mi, İskeletsel mi?)

Haftanın vakası

ORTA

12 yaş, erkek. Molar ilişki Sınıf II yarım birim. SNA 83°, SNB 80°, ANB 3°. Üst kesiciler prokline, profil hafif konveks.

Soru: Bu Sınıf II ağırlıklı olarak dental mi, iskeletsel mi?

Yorum: Ağırlıklı olarak dental. ANB normal sınırlarda; Sınıf II ilişki dişsel pozisyon ve üst kesici proklinasyonu ile açıklanıyor. Plan buna göre dentoalveolar mekaniklere yönelir. Araç 3 ile ayrımı belgeleyin.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Ayırımda kullanılan üç parametre sayın.
2. Maksiller prognati ile mandibular retrüzyonu nasıl ayırırsınız?
3. Hangi araçla ayrımı hızlıca kontrol edersiniz?

Kısa cevaplar: 1. ANB ve Wits, SNA/SNB, profil, kesici eğimleri. **2.** SNA yüksekse maksiller katkı, SNB düşükse mandibular katkı öne çıkar; profille birlikte yorumlanır. **3.** Araç 3 · Sınıf II – Sınıf III Görsel Ayırıcı.

☐ Okudum ☐ Vakayı çözdüm ☐ 3 soruyu cevapladım ☐ Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 25

Sınıf II bölüm 1 ve artmış overjet

Modül 05

Haftanın hedefi	Artmış overjette travma riskini ve erken müdahale gerekçesini değerlendirebilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 05 · Sagital Problemler: Sınıf II ve Sınıf III
Görsel Haritalar	Görsel Harita 67 (Sınıf II Bölüm 1) · Görsel Harita 77 (Artmış Overjet ve Travma Riski)

Haftanın vakası

ORTA

10 yaş, erkek. Overjet 9 mm. Dinlenmede alt dudak üst kesicilerin arkasında. Bir yıl önce üst santralde kron kırığı öyküsü var. Futbol oynuyor.

Soru: Erken müdahale için gerekçeleriniz nelerdir?

Yorum: Artmış overjet ve dudak tuzağı travma riskini artırır; öyküde zaten travma var. Overjetin erken azaltılması (ör. fonksiyonel aparey veya erken faz) değerlendirilir. Spor sırasında koruma konusunda bilgilendirme yapılır.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Dudak tuzağı nedir?
2. Artmış overjetle ilgili temel risk nedir?
3. Erken müdahalenin ana hedefi nedir?

Kısa cevaplar: 1. Alt dudağın dinlenmede üst kesicilerin arkasına yerleşmesi; proklinasyonu sürdürür. **2.** Üst kesicilerde travma riskinin artması. **3.** Overjeti azaltmak ve büyümeden yararlanarak sagital ilişkiyi iyileştirmek.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 26

Sınıf II bölüm 2

Modül 05

Haftanın hedefi	Sınıf II bölüm 2'de tedavi sırasını ve nüks riskini doğru kurabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 05 · Sagital Problemler: Sınıf II ve Sınıf III
Görsel Haritalar	Görsel Harita 68 (Sınıf II Bölüm 2)

Haftanın vakası

İLERİ

14 yaş, kız. Üst santraller retrokline, lateraller prokline. Overbite derin, alt kesiciler üst palatinal dişetine yakın. Yüksek dudak hattı. Molar Sınıf II yarım birim.

Soru: Tedavi sırasını nasıl kurarsınız?

Yorum: Önce üst santrallerin eğimi düzeltilir ve derin kapanış açılır; bu, mandibulanın serbest kalmasını ve sagital ilişkinin doğru değerlendirilmesini sağlar. Tork kontrolü önemlidir. Derin kapanışın nüks riski nedeniyle pekiştirme baştan planlanır.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Sınıf II bölüm 2'nin tipik kesici paterni nedir?
2. Neden önce kesiciler ve derin kapanış ele alınır?
3. Bu vakalarda hangi unsur nükse eğilimlidir?

Kısa cevaplar: 1. Retrokline santraller, prokline lateraller ve derin kapanış. **2.** Retrokline kesiciler mandibulayı geride tutabilir; düzeltildiklerinde sagital ilişki daha doğru okunur. **3.** Derin kapanış ve kesici eğimi.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 27

Fonksiyonel apareyler: Twin Block ve Herbst

Modül 05

Haftanın hedefi	Fonksiyonel aparey için doğru hastayı ve doğru zamanı seçebilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 05 · Sagital Problemler: Sınıf II ve Sınıf III
Görsel Haritalar	Görsel Harita 15 (Fonksiyonel Apareyler) · Görsel Harita 70 (Herbst ve Sabit Fonksiyonel Apareyler) · Görsel Harita 71 (Twin Block)

Haftanın vakası

ORTA

11 yaş, erkek. Büyüme atılımına yakın. SNA 81°, SNB 75°, ANB 6°, FMA 24°. Overjet 8 mm. Aile ve hasta uyumlu.

Soru: Bu hasta fonksiyonel aparey için uygun aday mı?

Yorum: Evet. Mandibular retrüzyona bağlı iskeletsel Sınıf II, normal vertikal patern, büyüme atılımına yakınlık ve iyi uyum uygun koşullardır. Hareketli ya da sabit aparey seçimi uyum ve hasta tercihiyle yapılır.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Fonksiyonel aparey için en uygun dönem nedir?
2. Hareketli ve sabit fonksiyonel aparey arasındaki pratik fark nedir?
3. Tipik dentoalveolar yan etki nedir?

Kısa cevaplar: 1. Büyüme atılımı dönemi veya ona yakın dönem. **2.** Hareketli aparey uyuma bağlıdır; sabit aparey uyum bağımlılığını azaltır. **3.** Alt kesici proklinasyonu.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 28

Sınıf II elastikleri ve kamuflaj çekimleri

Modül 05

Haftanın hedefi	Sınıf II elastiklerinin yan etkilerini bilip hangi hastada sınırlandırılması gerektiğini söyleyebilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 05 · Sagital Problemler: Sınıf II ve Sınıf III
Görsel Haritalar	Görsel Harita 69 (Sınıf II Elastikleri: Ne Zaman, Ne Zaman Değil) · Görsel Harita 72 (Sınıf II Kamuflaj Çekimleri)

Haftanın vakası

İLERİ

16 yaş, kız. Sınıf II yarım birim. FMA 33°. Alt kesiciler zaten prokline (IMPA 100°). Hafif açık kapanış eğilimi.

Soru: Uzun süreli Sınıf II elastik uygun mu? Alternatifler nelerdir?

Yorum: Dikkatli olunmalı. Sınıf II elastikleri alt kesicileri daha da öne eğer ve alt molarları ekstrüze edebilir; hiperdiverjan bir hastada bu mandibulanın posteriora rotasyonuna ve profilin kötüleşmesine yol açabilir. Kamuflaj çekimi veya mini vida destekli mekanikler alternatif olarak değerlendirilir.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Sınıf II elastiklerinin üç yan etkisini sayın.
2. Hangi hastada uzun süreli kullanım sınırlanır?
3. Kamuflaj çekiminde üst kesiciler geri alınırken neye dikkat edilir?

Kısa cevaplar: 1. Alt kesici proklinasyonu, alt molar ekstrüzyonu, oklüzal düzlem rotasyonu, üst kesici ekstrüzyonu. **2.** Hiperdiverjan, alt kesicileri zaten prokline veya periodontal desteği zayıf hastada. **3.** Tork kontrolüne; kesicilerin aşırı retroklinasyonundan kaçınılır.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 29

Sınıf III erken teşhis ve psödo Sınıf III

Modül 05

Haftanın hedefi	Psödo Sınıf III'ü gerçek Sınıf III'ten ayırıp aileye doğru bilgi verebilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 05 · Sagital Problemler: Sınıf II ve Sınıf III
Görsel Haritalar	Görsel Harita 13 (Sınıf III: Erken Teşhis) · Görsel Harita 75 (Psödo Sınıf III)

Haftanın vakası

ORTA

7 yaş, kız. Anterior çapraz kapanış. Sentrik ilişkide kesiciler uç uca gelebiliyor. Dinlenmede profil düz. Ailede belirgin Sınıf III öyküsü yok.

Soru: Bu tablo ne düşündürür? Ne önerirsiniz?

Yorum: Psödo Sınıf III ihtimali: sentrik ilişkide uç uca temas ve düz profil fonksiyonel bir ön kaymayı düşündürür. Kesici engelinin erken düzeltilmesi değerlendirilir ve büyüme takibi planlanır.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Psödo ve gerçek Sınıf III'ü ayıran temel bulgu nedir?
2. Aile öyküsü neden önemlidir?
3. Erken teşhiste bakılacak üç bulgu sayın.

Kısa cevaplar: 1. Psödoda sentrik ilişkide kesiciler uç uca gelebilir; gerçekte negatif overjet sürer. **2.** Gerçek iskeletsel Sınıf III'te ailesel eğilim sık görülür ve büyüme beklentisini etkiler. **3.** CR-CO farkı, profil (dinlenmede), kesici eğimleri, aile öyküsü, molar ilişki.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 30

Yüz maskesi ile protraksiyon ve Sınıf III kamuflaj

Modül 05

Haftanın hedefi	Maksiller retrüzyonda erken protraksiyonun yerini ve aileye anlatılacak sınırları bilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 05 · Sagital Problemler: Sınıf II ve Sınıf III
Görsel Haritalar	Görsel Harita 74 (Yüz Maskesi ile Protraksiyon) · Görsel Harita 73 (Sınıf III Kamuflaj)

Haftanın vakası

İLERİ

8 yaş, erkek. SNA 77°, SNB 80°, ANB −3°. Negatif overjet −2 mm. Orta yüz geride görünüyor. Sentrik ilişkide uç uca gelemiyor.

Soru: Hangi tedavi düşünülebilir ve aileye ne anlatırsınız?

Yorum: Maksiller retrüzyona bağlı iskeletsel Sınıf III; erken dönemde yüz maskesi ile protraksiyon (gerekirse RME ile birlikte) düşünülebilir. Aileye, büyüme süresince nüks olabileceği ve ileride kamuflaj veya cerrahi ihtiyacının doğabileceği açıkça anlatılır.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Yüz maskesi için ideal dönem nedir?
2. Sınıf III kamuflajında kesiciler nasıl hareket ettirilir?
3. Aileye mutlaka söylenmesi gereken nedir?

Kısa cevaplar: 1. Erken karma dişlenme, maksiller büyüme sürerken. **2.** Üst kesiciler öne, alt kesiciler geri eğilir (kompansasyon). **3.** Büyümenin sonucu değiştirebileceği ve ileride ek tedavi gerekebileceği.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 31

Ortognatik cerrahi sınırı ve molar ilişkisinin düzeltilmesi

Modül 05

Haftanın hedefi	Cerrahiyi düşündüren bulguları tanıyıp dekompansasyon kavramını hastaya anlatabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 05 · Sagital Problemler: Sınıf II ve Sınıf III
Görsel Haritalar	Görsel Harita 76 (Ortognatik Cerrahi Ne Zaman?) · Görsel Harita 78 (Molar İlişkisini Düzeltme)

Haftanın vakası

İLERİ

20 yaş, kadın. ANB 9°, overjet 11 mm, belirgin mandibular retrüzyon. Profil şikâyeti belirgin. Alt kesiciler prokline.

Soru: Kamuflaj mı, cerrahi mi? Cerrahi seçilirse ortodontik hazırlık nasıl olur?

Yorum: Uyumsuzluğun büyüklüğü ve profil şikâyeti kamuflajın sınırlarını zorlar; ortognatik cerrahi konsültasyonu önerilir. Cerrahi seçilirse ortodontik hazırlıkta dekompansasyon yapılır: alt kesiciler kaide kemiğe göre daha dik konuma getirilir, bu nedenle overjet geçici olarak artabilir.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Cerrahiyi düşündüren üç bulgu sayın.
2. Dekompansasyon nedir?
3. Molar ilişkisini düzeltmenin üç yolu nedir?

Kısa cevaplar: 1. Büyük iskeletsel uyumsuzluk, belirgin profil şikâyeti, kesicilerde kompansasyon payının tükenmesi, tamamlanmış büyüme. **2.** Kesicilerin doğal kompansasyonunun kaldırılıp kaide kemiğe göre doğru eğime getirilmesi. **3.** Büyüme yönlendirme, dentoalveolar hareket (distalizasyon, elastikler), çekimli kamuflaj veya cerrahi.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

MODÜL 06 · HAFTA 32–38

Vertikal ve Transversal Problemler

Bu bölümde 7 hafta var. Başlamadan önce Başucu Kitabı'nda Modül 06'in giriş sayfasını okuyun.

Hafta 32

Açık kapanış: dental, fonksiyonel, iskeletsel

Modül 06

Haftanın hedefi	Açık kapanışın tipini ayırıp nedene yönelik plan yapabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 06 · Vertikal ve Transversal Problemler
Görsel Haritalar	Görsel Harita 4 (Açık Kapanış) · Görsel Harita 79 (Açık Kapanış: Dental, Fonksiyonel, İskeletsel)

Haftanın vakası

ORTA

9 yaş, kız. Anterior açık kapanış 3 mm. Parmak emme alışkanlığı devam ediyor. FMA 26°. Molar ilişki Sınıf I.

Soru: Bu açık kapanışın tipi nedir? İlk hedefiniz ne olur?

Yorum: Vertikal iskeletsel patern normal; tablo alışkanlığa bağlı dental açık kapanışı düşündürür. İlk hedef alışkanlığın bırakılmasıdır; aile ve çocukla birlikte planlanır, gerekirse hatırlatıcı aparey düşünülür.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Açık kapanışın üç tipi nedir?
2. İskeletsel açık kapanışın iki göstergesi nedir?
3. Alışkanlığı nasıl sorgularsınız?

Kısa cevaplar: 1. Dental, fonksiyonel (dil ve alışkanlık kaynaklı) ve iskeletsel. **2.** Yüksek FMA ve SN-GoMe, artmış ön alt yüz yüksekliği. **3.** Çocuğa ve aileye ayrı ayrı, yargılamadan; ne zaman, ne sıklıkta ve hangi durumlarda.

☐ Okudum ☐ Vakayı çözdüm ☐ 3 soruyu cevapladım ☐ Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 33

Alışkanlıklar: parmak emme, dil itimi, dil ızgarası

Modül 06

Haftanın hedefi	Dil itimini muayenede tanıyıp gerekirse multidisipliner yönlendirme yapabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 06 · Vertikal ve Transversal Problemler
Görsel Haritalar	Görsel Harita 80 (Parmak Emme ve Dil İtimi) · Görsel Harita 81 (Dil Izgarası)

Haftanın vakası

ORTA

11 yaş, erkek. Yutkunmada dil kesiciler arasına giriyor. Konuşmada "s" sesinde bozulma var. Anterior açık kapanış 2 mm.

Soru: Plan nasıl olur? Kimi ekibe dahil edersiniz?

Yorum: Dil itimi ve buna eşlik eden konuşma bozukluğu. Konuşma terapistiyle multidisipliner çalışma önerilir. Gerekirse dil ızgarası değerlendirilir. Pekiştirme döneminde nüks riski yüksek olduğu için takip sık tutulur.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Dil itimini muayenede nasıl görürsünüz?
2. Dil ızgarasının amacı nedir?
3. Neden nüks riski yüksektir?

Kısa cevaplar: 1. Hastadan yutkunmasını isteyip dudakları hafifçe ayırarak dilin konumunu gözlemleyerek. **2.** Dilin kesiciler arasına girmesini engellemek ve doğru dinlenme konumunu desteklemek. **3.** Kas fonksiyonu değişmezse kuvvet dengesi açık kapanışı yeniden oluşturabilir.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 34

Derin kapanış: intrüzyon mu, ekstrüzyon mu?

Modül 06

Haftanın hedefi	Derin kapanışta hangi diş grubunun hareket ettirileceğine kesici görünürlüğü ve vertikal paterne göre karar verebilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 06 · Vertikal ve Transversal Problemler
Görsel Haritalar	Görsel Harita 5 (Derin Kapanış) · Görsel Harita 82 (Derin Kapanış: İntrüzyon mu, Ekstrüzyon mu?) · Görsel Harita 83 (Spee Eğrisini Düzeltme)

Haftanın vakası

İLERİ

15 yaş, kız. Overbite 6 mm. Dinlenmede üst kesici görünürlüğü fazla, gülüşte dişeti görünüyor. FMA 22°. Alt Spee eğrisi derin.

Soru: Derin kapanışı nasıl açarsınız?

Yorum: Üst kesici görünürlüğü fazla olduğu için üst kesici intrüzyonu öncelikli tercih olur. Spee eğrisinin düzeltilmesi için alt kesici intrüzyonu ve/veya posterior ekstrüzyon da planlanabilir; hipodiverjana yakın patern posterior ekstrüzyonu daha iyi tolere eder.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Karar verirken kullanılan iki kriter nedir?
2. Spee eğrisini düzeltmenin iki yolu nedir?
3. Derin kapanış tedavisinden sonra nüksü önlemek için ne planlanır?

Kısa cevaplar: 1. Dinlenme ve gülüşte üst kesici görünürlüğü ile vertikal patern. **2.** Kesici intrüzyonu ve premolar ekstrüzyonu (ya da ikisinin birlikte kullanılması). **3.** Uygun kesici eğimi ve kesici temasları, pekiştirme planı.

☐ Okudum ☐ Vakayı çözdüm ☐ 3 soruyu cevapladım ☐ Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 35

Hiperdiverjan ve hipodiverjan patern

Modül 06

Haftanın hedefi	Vertikal paterne göre kaçınılacak ve tercih edilecek mekanikleri sayabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 06 · Vertikal ve Transversal Problemler
Görsel Haritalar	Görsel Harita 84 (Hiperdiverjan Patern) · Görsel Harita 85 (Hipodiverjan Patern) · Görsel Harita 42 (Vertikal Patern: FMA ve SN-GoMe)

Haftanın vakası

İLERİ

14 yaş, erkek. FMA 35°, SN-GoMe 40°. Uzun alt yüz, dudak yetmezliği. Sınıf II yarım birim, açık kapanış eğilimi.

Soru: Planlamada hangi mekaniklerden kaçınırsınız? Hangi seçenekler öne çıkar?

Yorum: Hiperdiverjan patern: molar ekstrüzyonuna yol açan mekaniklerden (uzun süreli Sınıf II elastikleri, kontrolsüz genişletme) kaçınılır. Vertikal kontrol öncelikli olur; mini vida ile posterior intrüzyon gibi seçenekler değerlendirilir.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Hiperdiverjan hastada kaçınılacak iki mekanik sayın.
2. Hipodiverjan paternin derin kapanış tedavisindeki etkisi nedir?
3. FMA ve SN-GoMe için klasik normlar nelerdir?

Kısa cevaplar: 1. Molar ekstrüzyonuna yol açan mekanikler: uzun süreli Sınıf II elastikleri, kontrolsüz posterior ekstrüzyon. **2.** Posterior ekstrüzyonu daha iyi tolere eder, ama derin kapanış ve nüks eğilimi daha fazladır. **3.** FMA yaklaşık 25°, SN-GoMe yaklaşık 32°.

☐ Okudum ☐ Vakayı çözdüm ☐ 3 soruyu cevapladım ☐ Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 36

Posterior çapraz kapanış ve makaslama kapanış

Modül 06

Haftanın hedefi	Tek dişlik dental çapraz kapanışı iskeletsel transversal darlıktan ayırabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 06 · Vertikal ve Transversal Problemler
Görsel Haritalar	Görsel Harita 6 (Çapraz Kapanış) · Görsel Harita 86 (Posterior Çapraz Kapanış: Kompanse mi, Genişlet mi?) · Görsel Harita 88 (Makaslama Kapanış)

Haftanın vakası

ORTA

24 yaş, kadın. Yalnızca sol üst birinci molar çapraz kapanışta. Üst arkın genişliği klinikte yeterli, dişin kendisi palatinale eğik.

Soru: Bu çapraz kapanış dental mi, iskeletsel mi? Nasıl düzeltirsiniz?

Yorum: Dental (lokal). Üst ark genişliği yeterli, tek diş palatinale eğik. Lokal mekanikle (ör. ark teli ile bukkal hareket veya çapraz elastik) düzeltilir; RME gerekmez. Çapraz elastiğin ekstrüzyon etkisi izlenir.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Dental ve iskeletsel posterior çapraz kapanışı nasıl ayırırsınız?
2. Makaslama kapanış nedir?
3. Çapraz elastiğin tipik yan etkisi nedir?

Kısa cevaplar: 1. Diş eğimleri ve ark genişliği: iskeletselde üst çene kaide kemiği dardır, dişler çoğu zaman bukkale kompanse eğiktir. **2.** Üst posterior dişlerin alttakilerin tamamen bukkalinde kapanması. **3.** Dişlerde ekstrüzyon.

☐ Okudum ☐ Vakayı çözdüm ☐ 3 soruyu cevapladım ☐ Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 37

Anterior çapraz kapanış ve fonksiyonel kayma

Modül 06

Haftanın hedefi	Anterior çapraz kapanışta yer, overbite ve kayma ilişkisini birlikte değerlendirebilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 06 · Vertikal ve Transversal Problemler
Görsel Haritalar	Görsel Harita 87 (Anterior Çapraz Kapanış) · Görsel Harita 89 (Fonksiyonel Kayma)

Haftanın vakası

ORTA

26 yaş, erkek. Yalnızca sağ üst lateral kesici çapraz kapanışta. Arkta lateral için yer yaklaşık 2 mm eksik. Overbite normal.

Soru: Düzeltme sırasını nasıl kurarsınız?

Yorum: Önce lateral için yer açılır, sonra kesici labiale hareket ettirilir. Hareket sırasında kapanış engelini kaldırmak için geçici ısırma yükseltmeleri düşünülebilir. Düzeltmeden sonra normal overbite sonucun korunmasına yardımcı olur.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Anterior çapraz kapanışta önce neye bakarsınız?
2. Yer eksikliği neden önce çözülür?
3. Overbite'ın sonuca etkisi nedir?

Kısa cevaplar: 1. Dişin dental mi, iskeletsel bir tablonun parçası mı olduğuna ve CR-CO farkına. **2.** Yer olmadan diş labiale taşınamaz; zorlanırsa komşu dişleri iter. **3.** Yeterli overbite düzeltilen kesiciyi yerinde tutmaya yardımcı olur.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 38

Dişeti gülüşü, sütür olgunluğu ve genişletme sınırları

Modül 06

Haftanın hedefi	Erişkinde transversal darlıkta periodontal sınırları gözeterek seçenekleri anlatabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 06 · Vertikal ve Transversal Problemler
Görsel Haritalar	Görsel Harita 90 (Dişeti Gülüşü) · Görsel Harita 91 (Sütür Olgunluğu ve Yaş) · Görsel Harita 92 (Genişletmede Dişeti ve Kemik Sınırları)

Haftanın vakası

İLERİ

18 yaş, kadın. Bilateral posterior çapraz kapanış, iskeletsel transversal darlık. İnce dişeti fenotipi, bukkal kemik ince görünüyor. Premolarlar zaten bukkale eğik.

Soru: Yalnızca dental genişletme uygun mu? Hangi seçenekleri değerlendirirsiniz?

Yorum: Dental genişletme riskli: ince fenotipte ve zaten bukkale eğik dişlerde dişeti çekilmesi ve kemik kaybı riski artar. Mini vida destekli iskeletsel genişletme veya cerrahi destekli genişletme değerlendirilir; periodontal görüş alınır.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. İnce dişeti fenotipinde genişletmenin riski nedir?
2. Sütür olgunluğu neden önemlidir?
3. Dişeti gülüşünün dört nedenini sayın.

Kısa cevaplar: 1. Dişeti çekilmesi ve bukkal kemik kaybı. **2.** İskeletsel genişletmenin yapılabilirliğini ve yöntem seçimini belirler. **3.** Vertikal maksiller fazlalık, dentoalveolar ekstrüzyon, kısa veya hiperaktif üst dudak, pasif sürme.

☐ Okudum ☐ Vakayı çözdüm ☐ 3 soruyu cevapladım ☐ Takip kâğıdına işaretledim

MODÜL 07 · HAFTA 39–43

Yardımcı Mekanikler

Bu bölümde 5 hafta var. Başlamadan önce Başucu Kitabı'nda Modül 07'in giriş sayfasını okuyun.

Hafta 39

Boşluk kapama: elastik zincir, kayma ve halka mekaniği

Modül 07

Haftanın hedefi	Boşluk kapama sırasında tork ve overbite kaybını fark edip nedenini düzeltebilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 07 · Yardımcı Mekanikler
Görsel Haritalar	Görsel Harita 93 (Elastik Zincirle Boşluk Kapama) · Görsel Harita 94 (Kayma Mekaniği) · Görsel Harita 95 (Halka (Loop) Mekaniği)

Haftanın vakası

ORTA

Dört premolar çekimli vaka, boşluk kapama aşaması. Kesicilerde overbite derinleşiyor, üst kesiciler dikleşiyor (tork kaybı). Yüksek kuvvetle elastik zincir kullanılıyor, tel boyutu küçük.

Soru: Sorunun nedeni nedir? Ne değiştirirsiniz?

Yorum: Yetersiz rijitlikte tel ve fazla kuvvet: kesiciler kontrolsüz geri eğiliyor, ark deforme oluyor. Seviyelemenin tamamlandığından emin olunur, slotu daha iyi dolduran rektangüler çelik tele geçilir, kuvvet azaltılır ve tork kontrol edilir.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Kayma ve halka mekaniği arasındaki temel fark nedir?
2. Tork kaybını gösteren iki bulgu sayın.
3. Boşluk kapamaya başlamadan önceki iki şart nedir?

Kısa cevaplar: 1. Kaymada braket tel üzerinde kayar (sürtünme vardır); halkada kuvvet ve moment telin büküm geometrisinden gelir. **2.** Kesicilerin dikleşmesi, overbite'ın derinleşmesi, kanin ve premolarlarda tipping. **3.** Seviyelemenin tamamlanması ve uygun rektangüler çalışma teli.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 40

Tork ve rotasyon kontrolü

Modül 07

Haftanın hedefi	Rotasyonun ve torkun neden kaybolduğunu ve nasıl korunacağını açıklayabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 07 · Yardımcı Mekanikler
Görsel Haritalar	Görsel Harita 96 (Tork Kontrolü) · Görsel Harita 97 (Rotasyon Düzeltme)

Haftanın vakası

ORTA

15 yaş, kız. Üst sağ lateral kesici başlangıçta belirgin rotasyonlu. Düzeltme tamamlandı, aile "geri döner mi?" diye soruyor.

Soru: Rotasyon nüksünü azaltmak için neler planlanır?

Yorum: Rotasyon tedavinin erken döneminde düzeltilir, gerektiğinde hafif aşırı düzeltme yapılır ve bu konum bitirmeye kadar korunur. Pekiştirmede sabit lingual pekiştirme düşünülür. Seçilmiş vakalarda suprakrestal fiberotomi seçeneği tartışılabilir.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Rotasyon nüksünün temel nedeni nedir?
2. Torkun ifadesini ne etkiler?
3. Rotasyon düzeltmesi neden erken yapılır?

Kısa cevaplar: 1. Suprakrestal dişeti liflerinin yeniden düzenlenmesinin yavaş olması. **2.** Tel ile slot arasındaki boşluk, tel boyutu ve malzemesi, braket konumu. **3.** Yeni konumda daha uzun süre kalması stabiliteye katkı sağlar.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 41

Gömülü diş traksiyonu

Modül 07

Haftanın hedefi	Gömülü kanin traksiyonunda hazırlık, kuvvet yönü ve uyarı işaretlerini sayabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 07 · Yardımcı Mekanikler
Görsel Haritalar	Görsel Harita 98 (Gömülü Diş Traksiyonu)

Haftanın vakası

İLERİ

13 yaş, erkek. Sol üst kanin palatinalde gömülü. Arkta kanin için yer mevcut. Ek görüntüleme ile pozisyon belirlenmiş, komşu köklerde rezorpsiyon yok.

Soru: Traksiyon öncesinde ve sırasında neler planlarsınız?

Yorum: Yer korunur ve rijit bir ankraj ünitesi hazırlanır. Cerrahi açma ile ataşman yerleştirildikten sonra hafif kuvvetle, kuvvet yönü komşu köklerden uzağa olacak şekilde traksiyon yapılır. İlerleme düzenli klinik ve radyografik kontrolle izlenir.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Traksiyon öncesi üç hazırlık sayın.
2. Kuvvet yönü neden önemlidir?
3. Ankiloz şüphesini hangi bulgular düşündürür?

Kısa cevaplar: 1. Yeterli yer, rijit ankraj (rektangüler tel veya ek destek), kesin 3B pozisyon, cerrahla ortak plan. **2.** Kuvvet komşu köklere doğruysa kök rezorpsiyonu riski artar. **3.** Uzun süre hareket olmaması ve ankraj dişlerin intrüze olması; ayrıntılar Rehber 4'te.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 42

Molar dikleştirme, lingual ark, quad helix ve pendulum

Modül 07

Haftanın hedefi	Yardımcı apareylerin endikasyonlarını ve yan etkilerini bir tabloda karşılaştırabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 07 · Yardımcı Mekanikler
Görsel Haritalar	Görsel Harita 99 (Molar Dikleştirme) · Görsel Harita 100 (Lingual Ark ve Quad Helix) · Görsel Harita 101 (Pendulum Apareyi)

Haftanın vakası

ORTA

45 yaş, erkek. Sol alt birinci molar uzun süredir eksik. Sol alt ikinci molar meziale eğilmiş. İmplant için yer açılması planlanıyor.

Soru: Hangi mekanik düşünülür? Hangi yan etkiyi izlersiniz?

Yorum: Molar dikleştirme ile implant yeri açılabilir ve distal kök yüzeyindeki periodontal durum iyileşebilir. Dikleştirme sırasında moların ekstrüzyonu ve oklüzal temaslar izlenir. Periodontal durum ve implant hekimiyle ortak hedef baştan belirlenir.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Molar dikleştirmenin tipik yan etkisi nedir?
2. Quad helix hangi durumda kullanılır?
3. Pendulumda ankraj kaybı nasıl görülür?

Kısa cevaplar: 1. Moların ekstrüzyonu ve erken oklüzal temas. **2.** Üst arkta hafif-orta dentoalveolar genişletme ve molar derotasyonu gerektiğinde. **3.** Premolar ve kesicilerin meziale gelmesi, kesici proklinasyonu; molarlarda distal tipping.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 43

Ekstrüzyon, intrüzyon arkları ve elastik tipleri

Modül 07

Haftanın hedefi	Ortodontik ekstrüzyon endikasyonunu ve intrüzyon arklarının yan etkilerini açıklayabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 07 · Yardımcı Mekanikler
Görsel Haritalar	Görsel Harita 102 (Ekstrüzyon Mekaniği) · Görsel Harita 103 (İntrüzyon Arkları) · Görsel Harita 104 (Elastik Tipleri ve Kuvvetleri)

Haftanın vakası

İLERİ

30 yaş, kadın. Üst sağ santral kesicide dişeti altına uzanan kron kırığı. Kök boyu yeterli, endodontik tedavi yapılmış. Protez hekimi sağlıklı bir restorasyon sınırı istiyor.

Soru: Ortodonti nasıl katkı sağlar? Neye dikkat edilir?

Yorum: Ortodontik ekstrüzyon (zorla sürme) ile kırık sınırı dişeti üstüne getirilebilir. Hedef miktar protez hekimiyle birlikte belirlenir, kök-kron oranı gözetilir, yeni konumda pekiştirme süresi planlanır; gerekirse periodontal düzenleme eklenir.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Ortodontik ekstrüzyonun tipik endikasyonu nedir?
2. İntrüzyon arkının iki yan etkisi nedir?
3. Elastik seçerken iki kriter nedir?

Kısa cevaplar: 1. Dişeti altına uzanan kırık veya çürükte restorasyon sınırını ortaya çıkarmak. **2.** Kesici proklinasyonu ve molarlarda distal tipping/ekstrüzyon. **3.** İstenen kuvvet ve elastiğin uzama mesafesi; ayrıca hastanın uyumu.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

MODÜL 08 · HAFTA 44–48

Bitirme ve Stabilite

Bu bölümde 5 hafta var. Başlamadan önce Başucu Kitabı'nda Modül 08'in giriş sayfasını okuyun.

Hafta 44

Bitirme kontrol listesi ve braket repozisyonu

Modül 08

Haftanın hedefi	Braketleri sökmeden önce bitirme kontrol listesini eksiksiz uygulayabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 08 · Bitirme ve Stabilite
Görsel Haritalar	Görsel Harita 105 (Bitirme Kontrol Listesi) · Görsel Harita 106 (Braketi Yeniden Konumlandırma)

Haftanın vakası

ORTA

Tedavinin 22. ayı. Sağ ve sol kanin bölgesinde marjinal sırt seviyeleri farklı. Panoramikte üst sağ lateral kesicinin kökü distale eğik. Hasta braketlerin bir an önce çıkmasını istiyor.

Soru: Braketleri sökmeden önce ne yaparsınız?

Yorum: Bitirme kontrol listesi uygulanır. Marjinal sırt farkı ve kök eğimi için ilgili braketler yeniden konumlandırılır ve kısa bir bitirme aşaması planlanır. Hastaya bu adımın neden sonucu kalıcı kılmak için gerekli olduğu kısa ve net anlatılır.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Bitirme kontrol listesinden beş madde sayın.
2. Braket repozisyonu ne zaman yapılmalıdır?
3. Marjinal sırt seviyesi neden önemlidir?

Kısa cevaplar: 1. Molar ve kanin ilişkisi, overjet ve overbite, orta hatlar, marjinal sırtlar, kök paralelliği, kontaklar, oklüzal düzlem, tork. **2.** Seviyeleme sırasında veya bitirmeden önce, sorun fark edilir edilmez; sona bırakılmamalıdır. **3.** Doğru kontaklar, periodontal sağlık ve dengeli oklüzyon için.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 45

Kök paralelliği ve orta hat

Modül 08

Haftanın hedefi	Orta hat sapmasının nedenini ayırıp bitirmede doğru mekaniği seçebilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 08 · Bitirme ve Stabilite
Görsel Haritalar	Görsel Harita 107 (Kök Paralelliği) · Görsel Harita 108 (Orta Hattı Bitirme) · Görsel Harita 10 (Orta Hat Sapmaları)

Haftanın vakası

ORTA

Dört premolar çekimli vaka, bitirme aşaması. Üst orta hat yüz orta hattıyla uyumlu. Alt orta hat 2 mm sağa kaymış. İskeletsel asimetri yok.

Soru: Nedeni nasıl ararsınız? Hangi mekanik düşünülür?

Yorum: Önce nedeni bulun: asimetrik boşluk kapama, çapraşıklığın tek tarafta fazla olması ya da fonksiyonel kayma. İskeletsel asimetri yoksa asimetrik mekanik veya asimetrik elastiklerle dental düzeltme yapılabilir. Kök paralelliği panoramikte ve klinikte kontrol edilir.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Orta hat sapmasının üç nedeni sayın.
2. Hangisi önce dışlanmalıdır?
3. Kök paralelliğini kontrol ederken neye dikkat edilir?

Kısa cevaplar: 1. Dental (asimetrik çapraşıklık, eksik diş), fonksiyonel kayma, iskeletsel asimetri. **2.** Fonksiyonel kayma ve iskeletsel asimetri. **3.** Panoramik görüntüde distorsiyon olabileceğine; klinik ve gerekirse ek görüntülemeyle birlikte değerlendirilir.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 46

Oklüzal oturma (settling) ve pekiştirme seçimi

Modül 08

Haftanın hedefi	Bitirmede posterior temasları iyileştirmeyi ve hastaya uygun pekiştirme apareyini seçmeyi planlayabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 08 · Bitirme ve Stabilite
Görsel Haritalar	Görsel Harita 109 (Oklüzal Oturma (Settling)) · Görsel Harita 110 (Pekiştirme Apareyi Seçimi)

Haftanın vakası

ORTA

17 yaş, erkek. Bitirme aşaması. Kesici ilişkileri iyi, ancak premolar bölgede posterior temaslar zayıf. Ağız hijyeni orta, uyum iyi.

Soru: Posterior temasları nasıl iyileştirirsiniz? Pekiştirmeyi neye göre seçersiniz?

Yorum: Settling için daha esnek bir bitirme teli veya kısa süreli dikey elastikler kullanılabilir. Pekiştirme seçimi başlangıçtaki problem tipine, nüks riskine, ağız hijyenine ve hastanın uyumuna göre yapılır; ayrıntılar Rehber 2'de.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Settling için kullanılan iki yöntem nedir?
2. Pekiştirme seçiminde üç kriter sayın.
3. Pekiştirme ayrıntılarını hangi materyalde bulursunuz?

Kısa cevaplar: 1. Esnek veya bölümlü bitirme teli ve kısa süreli dikey elastikler. **2.** Başlangıç problemi, nüks riski, ağız hijyeni, uyum, hastanın tercihi. **3.** Rehber 2 · Ortodontik Pekiştirme El Kitabı.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 47

Sabit lingual, Hawley ve şeffaf plak

Modül 08

Haftanın hedefi	Pekiştirme seçeneklerinin artı ve eksilerini hastaya iki dakikada anlatabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 08 · Bitirme ve Stabilite
Görsel Haritalar	Görsel Harita 111 (Sabit Lingual Pekiştirme) · Görsel Harita 112 (Hawley ve Şeffaf Plak) · Görsel Harita 20 (Pekiştirme ve Nüks)

Haftanın vakası

TEMEL

16 yaş, kız. Başlangıçta üst diastema ve alt kesicilerde rotasyonlar vardı. Ağız hijyeni orta. Kontrollere düzenli geliyor.

Soru: Hangi pekiştirmeyi önerirsiniz? Hastaya ne anlatırsınız?

Yorum: Diastema ve rotasyonlar nüks riski taşır; sabit lingual pekiştirme önerilir, gerekirse gece kullanılan hareketli bir plakla birlikte. Hastaya hijyen ve düzenli kontrol anlatılır; kopan bir bağlantının hemen fark edilip bildirilmesi gerektiği vurgulanır.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Sabit lingual pekiştirmenin iki endikasyonu nedir?
2. Hawley'in bir avantajı nedir?
3. Şeffaf plağın bir dezavantajı nedir?

Kısa cevaplar: 1. Başlangıçta diastema veya belirgin rotasyonlar, alt kesici çapraşıklığı. **2.** Ayarlanabilir olması ve oklüzal oturmaya izin vermesi. **3.** Uyuma bağlıdır ve zamanla aşınıp yenilenmesi gerekebilir.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 48

Nüksün nedenleri ve uzun dönem takip

Modül 08

Haftanın hedefi	Nüks eden bir vakayı suçlamadan analiz edip hastayla yeni bir plan konuşabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 08 · Bitirme ve Stabilite
Görsel Haritalar	Görsel Harita 113 (Nüksün Nedenleri) · Görsel Harita 114 (Uzun Dönem Takip)

Haftanın vakası

ORTA

21 yaş, kadın. Tedavi bitişinden üç yıl sonra alt kesicilerde çapraşıklık geri gelmiş. Hasta hareketli plakları bir yıl önce bıraktığını söylüyor.

Soru: Nüksün olası nedenleri nelerdir? Ne yaparsınız?

Yorum: Pekiştirme uyumsuzluğu ve yaşla birlikte devam eden fizyolojik değişimler. Durum yeniden değerlendirilir, başlangıç ve bitiş kayıtları karşılaştırılır. Hafif çapraşıklıkta sınırlı tedavi ve sonrasında uzun dönem pekiştirme planı hastayla birlikte konuşulur.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Nüksün üç nedenini sayın.
2. Uzun dönem takipte ne planlanır?
3. Pekiştirme hastaya nasıl anlatılır?

Kısa cevaplar: 1. Pekiştirme uyumsuzluğu, devam eden büyüme ve yaşla değişim, periodontal lif gerilimi, kas fonksiyonu, yetersiz bitirme. **2.** Belirli aralıklarla kontrol, pekiştirme apareyinin durumu, hijyen. **3.** Tedavinin parçası olarak ve en başta; dişlerin ömür boyu hareket etmeye eğilimli olduğu basit bir dille.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

MODÜL 09 · HAFTA 49–52

Yorumlu Klinik Vakalar

Bu bölümde 4 hafta var. Başlamadan önce Başucu Kitabı'nda Modül 09'in giriş sayfasını okuyun.

Hafta 49

Yorumlu vaka: erişkinde çapraşıklık

Modül 09

Haftanın hedefi	Erişkin bir çapraşıklık vakasını problem listesinden pekiştirmeye kadar baştan sona planlayabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 09 · Yorumlu Klinik Vakalar
Görsel Haritalar	Görsel Harita 115 (Vaka: Erişkinde Çapraşıklık)

Haftanın vakası

ORTA

32 yaş, kadın. Sınıf I, alt kesicilerde 5 mm çapraşıklık, üstte 2 mm. Profil düz. İnce dişeti fenotipi, ağız hijyeni iyi. Şikâyet: "Alt dişlerim gittikçe çapraşıklaşıyor."

Soru: Problem listesini, hedefleri ve mekanik seçeneklerini yazın.

Yorum: Problem: orta düzey alt ve hafif üst çapraşıklık, ince fenotip. Hedef: kesicileri aşırı öne almadan hizalamak ve periodontal destek korumak. Mekanik: IPR ve sınırlı ark şekillendirme ile çekimsiz plan düşünülebilir. Pekiştirme: sabit lingual pekiştirme ve uzun dönem takip.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Profil düzse kesici proklinasyonu neden sınırlanır?
2. İnce fenotipte hangi harekete dikkat edilir?
3. Bu vakada pekiştirme neden uzun süreli planlanır?

Kısa cevaplar: 1. Profil ve periodontal destek açısından kesicilerin öne alınmasının sınırı vardır. **2.** Kesicilerin labiale hareketine ve genişletmeye. **3.** Erişkinde çapraşıklığın yaşla ilerleme eğilimi devam eder.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 50

Yorumlu vakalar: büyüme döneminde Sınıf II ve erken Sınıf III

Modül 09

Haftanın hedefi	Büyüme dönemindeki iki zıt vakayı aynı problem listesi yapısıyla karşılaştırabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 09 · Yorumlu Klinik Vakalar
Görsel Haritalar	Görsel Harita 116 (Vaka: Büyüme Dönemi Sınıf II Bölüm 1) · Görsel Harita 117 (Vaka: Erken Sınıf III)

Haftanın vakası

İLERİ

Vaka A: 11 yaş, erkek. Sınıf II bölüm 1, overjet 8 mm, ANB 6°, FMA 25°, iyi uyum. Vaka B: 8 yaş, kız. Anterior çapraz kapanış, ANB −2°, SNA 78°, sentrik ilişkide uç uca gelemiyor, babada Sınıf III öyküsü.

Soru: Her iki vaka için problem listesini ve zamanlama kararını yazın.

Yorum: A: mandibular retrüzyona bağlı iskeletsel Sınıf II, normal vertikal patern, büyüme atılımına yakın; fonksiyonel aparey ile büyüme dönemi tedavisi düşünülür. B: maksiller retrüzyon ağırlıklı iskeletsel Sınıf III, ailesel eğilim; erken protraksiyon düşünülür, aileye nüks ve ileride ek tedavi olasılığı anlatılır.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. İki vakada ortak olan karar kriteri nedir?
2. Vaka B'de aileye ne mutlaka söylenir?
3. Vaka A'da hangi yan etki izlenir?

Kısa cevaplar: 1. Büyüme döneminin tedavi için bir fırsat olması. **2.** Büyümeyle nüks olabileceği ve ileride kamuflaj veya cerrahi gerekebileceği. **3.** Alt kesici proklinasyonu.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 51

Yorumlu vakalar: alışkanlığa bağlı açık kapanış ve asimetri

Modül 09

Haftanın hedefi	Vertikal ve transversal problemleri birlikte taşıyan vakalarda nedeni önce ayırabilmek.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 09 · Yorumlu Klinik Vakalar
Görsel Haritalar	Görsel Harita 118 (Vaka: Alışkanlığa Bağlı Açık Kapanış) · Görsel Harita 119 (Vaka: Asimetri ve Orta Hat)

Haftanın vakası

İLERİ

Vaka A: 10 yaş, kız. Parmak emmeye bağlı anterior açık kapanış 4 mm, üst çene dar, posterior çapraz kapanış yok. Vaka B: 15 yaş, erkek. Alt orta hat 3 mm sola, sentrik ilişkide değişmiyor, çene ucu da sola kaymış.

Soru: Her vakada önce neyi ayırırsınız ve plan ne olur?

Yorum: A: alışkanlığa bağlı dental açık kapanış; önce alışkanlık bırakılır, transversal darlık değerlendirilir, gerekirse genişletme ve dil konumu için destek planlanır. B: CR'de değişmeyen ve çene ucunu da içeren sapma iskeletsel asimetriyi düşündürür; ek görüntüleme ve büyüme takibi ile değerlendirilir, cerrahi konsültasyon gerekebilir.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Orta hat sapmasının iskeletsel olduğunu düşündüren bulgu nedir?
2. Alışkanlık bırakılmadan mekanik başlanırsa ne olur?
3. Asimetri vakasında büyüme neden takip edilir?

Kısa cevaplar: 1. Sentrik ilişkide düzelmemesi ve çene ucunun da sapmaya eşlik etmesi. **2.** Nüks riski artar ve tedavi uzar. **3.** Asimetri büyüme süresince artabilir; karar zamanlaması buna bağlıdır.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Hafta 52

Yorumlu vaka: uzayan tedavinin analizi

Modül 09

Haftanın hedefi	Uzayan bir tedaviyi sistematik olarak analiz edip yeni bir plan çıkarabilmek ve yılı tamamlamak.
Başucu Kitabı'nda okuyun	Modül 09 · Yorumlu Klinik Vakalar
Görsel Haritalar	Görsel Harita 120 (Vaka: Uzayan Tedavinin Analizi)

Haftanın vakası

İLERİ

17 yaş, kız. 20 ay olarak planlanan tedavi 30. ayında. Çekim boşlukları tam kapanmamış, molarlar beklenenden fazla meziale gelmiş, son altı ayda iki randevu kaçırılmış. Başlangıçta ankraj planı yazılmamış.

Soru: Tedavinin uzamasının nedenlerini sıralayın ve yeni planı yazın.

Yorum: Nedenler: ankraj planının olmaması ve ankraj kaybı, randevu düzensizliği, ara değerlendirmelerin atlanması. Yeni plan: güncel kayıtlarla yeniden teşhis, kalan boşluk ve hedefin yeniden yazılması, gerekirse mini vida ile ankraj, hastayla net bir zaman ve uyum planı. Araç 5 ile hataları tek tek işaretleyin.

ÖZ DEĞERLENDİRME · 3 SORU

1. Uzayan tedavide ilk adım nedir?
2. Bu vakada hangi planlama hatası belirleyiciydi?
3. Hangi araç bu analizi kolaylaştırır?

Kısa cevaplar: 1. Güncel kayıtlarla yeniden teşhis ve hedeflerin yeniden yazılması. **2.** Başlangıçta ankraj planının yapılmaması. **3.** Araç 5 · Planlama Hataları Radarı.

- [ ] Okudum
- [ ] Vakayı çözdüm
- [ ] 3 soruyu cevapladım
- [ ] Takip kâğıdına işaretledim

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal klinik muayenenin, hekimin kararının ve uzman görüşünün yerini almaz.

Sonraki adım

52 haftayı bitirdiniz mi? Önce Haftalık İlerleme Takip Kâğıdı'nda boş kalan haftalara dönün.

Sonra **100 Yorumlu Vaka Sorusu**'nu açın ve her bloğu süre tutarak çözün. Sefalometride zorlandığınız haftalar için **Sefalometrik Ölçüm Alıştırma Defteri**'ndeki 10 alıştırmayı yapın.

İkinci yıla başlarken Başucu Kitabı'nın **Modül 09 · Yorumlu Klinik Vakalar** bölümünü ve **Araç 5 · Planlama Hataları Radarı**'nı kendi vakalarınızla tekrar edin.